

Quistes funcionales

1. Introducción y relevancia clínica

Los **quistes funcionales del ovario** son **formaciones quísticas benignas** derivadas del **ciclo ovárico normal**, que aparecen y desaparecen espontáneamente durante la vida reproductiva.

Son una causa muy frecuente de **masa anexial** y de **dolor pélvico leve o incidentalomas ecográficos**.

La mayoría son **asintomáticos y autolimitados**, pero su principal relevancia clínica es **diferenciarlos de lesiones neoplásicas malignas**, evitando intervenciones innecesarias.

□ En EUNACOM es habitual que te pregunten:

- Qué es un quiste funcional y cómo se diferencia de uno patológico.
 - Conducta ante un quiste simple de 4 cm en mujer en edad fértil.
 - Manejo y seguimiento ecográfico según edad y características.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Durante el ciclo ovárico normal, bajo el estímulo de **FSH y LH**, se desarrollan folículos que maduran hasta ovular.

Cuando alguno de estos procesos se altera, puede formarse un **quiste funcional**.

Tipos de quistes funcionales:

Tipo	Origen fisiológico	Características
Quiste folicular	Folículo de Graaf que no ovula	Más frecuente; pared fina, contenido anecoico

Quiste del cuerpo lúteo	Retención de líquido o sangre tras ovulación	Pared más gruesa, posible contenido ecogénico
Quiste tecaluteínico	Estimulación excesiva por gonadotropinas	Asociado a embarazo múltiple o mola
Quiste hemorrágico	Sangrado dentro de un quiste funcional	Dolor agudo, imagen ecográfica mixta

☐ Son **dependientes de los cambios hormonales cíclicos**, por lo que **tienden a involucionar espontáneamente**.

3. Epidemiología y factores asociados

- Más frecuentes entre los **15 y 45 años**.
- Raros antes de la menarquia o después de la menopausia.
- Factores asociados:
 - Ciclos anovulatorios (adolescencia, perimenopausia).
 - Estimulación ovárica (tratamientos de fertilidad).
 - Uso reciente o suspensión de anticonceptivos hormonales.

4. Clínica

a.

Asintomáticos

- Hallazgo incidental en ecografía pélvica (mayoría).

b.

Sintomáticos

- Dolor pélvico leve o sensación de peso.
 - Dismenorrea o irregularidad menstrual.
 - Dolor súbito intenso: puede sugerir **torsión o rotura** del quiste.
 - Síntomas de compresión: poco frecuentes (en quistes grandes).
-

5. Diagnóstico diferencial

Causa	Diferencias clínicas o ecográficas
Endometrioma	Contenido denso, homogéneo (“vidrio esmerilado”), persistente
Cistoadenoma	Quiste grande, multilocular, sin regresión
Quiste dermoide	Componentes sólidos, calcificaciones, ecos mixtos
Absceso tubo-ovárico	Dolor intenso, fiebre, leucocitosis
Cáncer ovárico	Componente sólido, papilas, ascitis, edad >50 años

6. Exámenes complementarios

a.

Ecografía transvaginal (examen de elección)

Característica	Quiste funcional benigno
Forma	Redonda u ovalada
Pared	Fina y regular
Contenido	Anecoico (líquido claro)
Tabiques / nódulos	Ausentes
Flujo Doppler	Mínimo o ausente
Tamaño	<6 cm (generalmente)
☐ La ecografía transvaginal permite distinguir quistes funcionales (simples, transitorios) de orgánicos o neoplásicos (persistentes, complejos).	

b.

Marcadores tumorales

- **CA-125** puede solicitarse en:
 - Mujeres **>40 años**.
 - Quistes complejos o persistentes >6 semanas.
- No útil en diagnóstico de quistes funcionales, ya que puede elevarse por causas benignas (menstruación, endometriosis, EIP).

c.

Prueba de embarazo (β -hCG)

- Debe realizarse siempre en mujeres en edad fértil.
 - Excluye **embarazo ectópico** o **quistes tecaluteínicos** asociados.
-

7. Conducta clínica y manejo según edad y características

A.

Mujer premenopáusica (edad fértil)

Tipo de quiste	Tamaño	Conducta
Simple	<5 cm	Observación, sin seguimiento
Simple	5–7 cm	Control ecográfico en 6–8 semanas
Simple	>7 cm	Evaluar RM o laparoscopia
Complejo	Cualquier tamaño	Derivar a ginecología
Hemorrágico	<5 cm y sin síntomas	Control ecográfico
Hemorrágico con dolor	Manejo sintomático + control en 6–8 sem	

La mayoría se **resuelven espontáneamente** dentro de **1 a 3 ciclos menstruales**.

B.

Mujer posmenopáusica

- Todo quiste **>3 cm o con componente sólido** requiere estudio.
 - Evaluar **CA-125** y características ecográficas.
 - Quistes simples <3 cm pueden observarse (remanentes funcionales).
 - Derivar si hay:
 - Pared gruesa, tabiques, papilas o ascitis.
 - CA-125 >35 UI/ml.
-

C.

Tratamiento médico

- No se requiere tratamiento específico.
 - En casos recurrentes o dolorosos:
 - **Anticonceptivos orales combinados**: suprimen la ovulación y previenen nuevos quistes.
 - **AINES**: alivian dolor pélvico.
 - Educación sobre signos de alarma (dolor agudo, mareo, vómitos → sospechar torsión).
-

D.

Tratamiento quirúrgico

Indicaciones:

- Quistes persistentes >3 meses.
- Tamaño >7–8 cm.
- Aspecto complejo o sospechoso.

- Torsión o rotura con hemoperitoneo.

Opciones:

- **Laparoscopia:** técnica preferida (quistectomía conservadora).
- **Laparotomía:** en masas grandes o sospecha oncológica.

En mujeres jóvenes se preserva el ovario; en posmenopáusicas puede considerarse anexectomía.

8. Complicaciones

Complicación	Descripción
Torsión ovárica	Dolor agudo súbito, náuseas, vómitos; urgencia quirúrgica
Rotura	Dolor pélvico súbito, leve hemoperitoneo
Hemorragia interna	Dolor y signos de irritación peritoneal
Persistencia o recurrencia	Requiere estudio complementario

9. Pronóstico y seguimiento

- Excelente pronóstico.
- La mayoría involuciona espontáneamente.
- En mujeres con recurrencia o tratamiento hormonal, control ecográfico semestral.

- No aumenta el riesgo de malignidad si se maneja adecuadamente.

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Quiste funcional = resultado del ciclo ovárico normal.**
2. Tipos: **folicular, lúteo, tecaluteínico, hemorrágico.**
3. La **ecografía transvaginal** es el examen diagnóstico de elección.
4. La mayoría son **<6 cm** y desaparecen en **6–8 semanas**.
5. **ACO combinados** previenen recurrencias.
6. **Dolor agudo + masa anexial = descartar torsión.**
7. En **posmenopausia**, todo quiste >3 cm requiere estudio (CA-125).



Errores comunes

- Indicar cirugía precoz en quistes pequeños o simples.
- No solicitar prueba de embarazo en mujeres fértiles.
- Omitir control ecográfico de un quiste persistente.
- Confundir endometrioma con quiste funcional.
- No derivar masas complejas o con ascitis.

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **quistes funcionales** derivan del ciclo ovárico y son **benignos y transitorios**.
2. **Ecografía transvaginal** distingue quistes funcionales de neoplásicos.
3. La mayoría **involuciona en 6–8 semanas**.
4. Manejo conservador salvo complicaciones o tamaño >7 cm.
5. **ACO combinados** pueden prevenir recurrencias.
6. **Posmenopausia**: investigar todo quiste >3 cm o con elementos sólidos.
7. **Torsión y rotura** son las principales complicaciones agudas.